

Prise en charge de l'IVG jusqu'à 14 semaines

Méthodologie, organisation, consultations, techniques, douleur, prévention, suites & sources



Résumé : recommandations ANAES (mars 2001) pour la prise en charge de l'IVG jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée (SA), dans le cadre légal. Organisation des structures et de l'accueil, information et consultations pré-IVG, choix de la technique (chirurgicale ou médicamenteuse) et du mode d'anesthésie selon l'âge gestationnel, prise en charge de la douleur, prévention des complications infectieuses et de l'incompatibilité Rhésus, suites et suivi post-IVG.

■ **Périmètre — IVG médicamenteuse exclue de cette fiche :** le document source lui-même indique que ses recommandations sur l'IVG par **méthode médicamenteuse** sont remplacées par les recommandations HAS de **décembre 2010** (non incluses dans le PDF source, donc non reprises ici). Le PDF signale aussi que les passages de mars 2001 modifiés en 2010 apparaissent « en rouge » dans le document original — une information de couleur qui n'est **pas récupérable** lors de l'extraction du texte (limite technique, disclosed et non résolue silencieusement, cf. règle 5 du projet). Cette fiche reproduit fidèlement le texte tel qu'il apparaît dans le PDF source (donc déjà partiellement amendé, sans qu'on puisse distinguer 2001 de 2010) et porte principalement sur la **technique chirurgicale** et les éléments communs aux deux méthodes. Pour l'IVG médicamenteuse, se référer impérativement aux recommandations HAS 2010.

Méthodologie — grille ANAES

Grille à 3 niveaux : **grade A** (essais comparatifs randomisés de forte puissance, méta-analyses, analyses de décision bien menées) ; **grade B** (essais randomisés de faible puissance, études comparatives non randomisées bien menées, études de cohortes) ; **grade C** (études cas-témoins, séries de cas). « En l'absence de précision, les recommandations proposées correspondent à un **accord professionnel** » (citation littérale du texte source) — chip **AP** dans cette fiche. La grande majorité des recommandations de ce document sont non graduées (AP) ; seuls 8 énoncés portent un grade A/B/C explicite (détaillés ci-après).

Grille ANAES — A : preuve scientifique établie (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses) ; **B :** présomption scientifique (essais randomisés de faible puissance, cohortes) ; **C :** niveau de preuve moindre (cas-témoins, séries de cas) ; **AP :** accord professionnel (absence de précision de grade dans le texte source).

I-II. Structures de prise en charge, accueil et organisation

Thème	Recommandation
Nombre de structures	En nombre suffisant par département pour un accueil correct et rapide de toutes les demandes ; fonctionnement chaque semaine, sans interruption, toute l'année. (AP)
Jusqu'à 12 SA (84 j)	Structure intégrée à un établissement avec service de gynécologie-obstétrique, ou en convention avec un plateau technique permettant de prendre en charge l'ensemble des complications de l'IVG. (AP)
Au-delà de 12 SA	Prise en charge dans une structure disposant d'un plateau technique chirurgical, désignée et connue de tous les centres d'accueil du département. (AP)
Équipement	Chaque centre d'accueil doit disposer d'au moins un échographe avec sonde vaginale. Projet de service partagé par tout le personnel impliqué, avec formation spécifique à cette activité. (AP)
Délai de rendez-vous	Consultation obtenue dans les 5 jours suivant l'appel — l'IVG précoce réduit le risque de complications et élargit le choix des techniques. (AP)
Accueil téléphonique	Ligne téléphonique dédiée, connue et diffusée ; message clair et précis hors présence du personnel. (AP)
Accueil/secrétariat	Opérationnels pour répondre aux demandes, orienter vers les consultations préalables et informer sur les modalités de l'IVG ; signalés avec précision à l'entrée et dans l'établissement. (AP)
Mode de prise en charge	Sauf cas exceptionnel, IVG réalisées en ambulatoire ou en hôpital de jour (séjour < 12 heures). (AP)

III. Consultations pré-IVG

Prise en charge de l'IVG jusqu'à 14 semaines

Méthodologie, organisation, consultations, techniques, douleur, prévention, suites & sources



Thème	Recommandation
Information	Informations claires et précises sur la procédure (méthode médicamenteuse ou chirurgicale), les choix d'anesthésie (locale/générale) et le temps de réflexion, à l'oral et par documents écrits. (AP)
Entretien psychosocial	Un entretien d'information, de soutien et d'écoute doit pouvoir être proposé systématiquement, confié à des professionnels qualifiés pour cet accompagnement. (AP)
Âge gestationnel	Précisé par l'interrogatoire et l'examen clinique ; recours à une échographie possible sur place lors de la consultation. (AP)
Dépistage	Dépistage des IST (dont VIH) et frottis cervico-vaginaux proposés selon le contexte clinique. (AP)
Contraception ultérieure	Abordée et éventuellement prescrite dès la consultation précédant l'IVG ; recherche des raisons de l'échec ou de l'absence de contraception. (AP)
Procédure d'urgence	Permet de raccourcir le délai de réflexion pour les femmes dont l'âge gestationnel est situé entre 12 et 14 SA. (AP)
Bilan biologique	Groupe sanguin Rhésus avec recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) systématique pour toutes les patientes ; autres examens si besoin lors d'une éventuelle consultation préanesthésique. (AP)

IV. Techniques d'IVG — principes généraux

Dans tous les cas possibles, la femme choisit la technique (médicale ou chirurgicale) et le mode d'anesthésie (locale ou générale). (AP)
 La technique chirurgicale repose sur la dilatation du col et l'évacuation du contenu utérin par aspiration, en conditions strictes d'asepsie, éventuellement précédée d'une préparation cervicale médicamenteuse. La technique médicamenteuse associe mifépristone et prostaglandines — **se référer aux recommandations HAS de décembre 2010** pour cette méthode (hors périmètre de cette fiche, voir avertissement en page 1).

Recommandation	Grade
Préparation cervicale (lorsqu'elle est recommandée) — mifépristone 200 mg per os 36 à 48 heures avant aspiration.	A
Préparation cervicale (alternative) — misoprostol 400 µg par voie orale ou vaginale 3 à 4 heures avant aspiration.	A

La préparation cervicale, quel que soit le produit utilisé, ne nécessite pas d'hospitalisation. Le contrôle visuel du produit d'aspiration est indispensable. (AP) En postopératoire, toute patiente ayant bénéficié d'une sédation intraveineuse, d'une anesthésie générale ou périmédullaire doit séjourner en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI). (AP)

IV (suite). Technique selon l'âge gestationnel

Âge gestationnel	Conduite recommandée
Jusqu'à 7 SA révolues (49 j)	Techniques chirurgicale et médicale utilisables selon disponibilités et choix de la patiente. Risque d'échec de la technique chirurgicale inférieur à la technique médicale, mais plus élevé à cet âge gestationnel que plus tardivement. (AP)
8e-9e SA (50 à 63 j)	Deux techniques utilisables. Pour la technique chirurgicale, préparation cervicale médicamenteuse recommandée chez la nullipare (mifépristone 200 mg 36-48 h avant, ou misoprostol 400 µg 3-4 h avant). (AP)
10e-12e SA (64 à 84 j)	Technique chirurgicale = technique de choix. Préparation cervicale médicamenteuse recommandée (mêmes 2 options). (AP)
13e-14e SA (85 à 98 j)	Technique chirurgicale = technique de choix — évacuation par aspiration ± pinces spécifiques, nécessitant une formation spécifique. Préparation cervicale médicamenteuse recommandée. L'anesthésie locale éventuelle demande une très bonne maîtrise de la technique de dilatation-évacuation.

Recommandation	Grade
13e-14e SA — la technique chirurgicale est la technique de choix.	B

Prise en charge de l'IVG jusqu'à 14 semaines

Méthodologie, organisation, consultations, techniques, douleur, prévention, suites & sources



V. Prise en charge de la douleur — analgésie et anesthésie

L'IVG médicamenteuse est responsable de douleurs modérées à sévères pour plus de 50 % des femmes, liées principalement aux prostaglandines ; l'efficacité des traitements antalgiques proposés a été peu évaluée. (AP)

Recommandation	Grade
Lors des avortements par aspiration, l'anesthésie locale par bloc paracervical ne prévient pas la survenue de douleurs sévères pour environ le tiers des patientes.	C
L'injection de lidocaïne intracervicale (région isthmique, orifice interne du col) diminue significativement le score de douleur par comparaison à la technique de bloc paracervical précédente.	B
Facteurs de risque de douleur intense : jeune âge, peur de l'acte, utérus rétroversé, antécédents de dysménorrhée, grossesses les plus précoces et les plus avancées — justifient des antalgiques efficaces en préopératoire (AL) ou la proposition d'une anesthésie générale.	C
L'administration d'ibuprofène (AINS) diminue les scores de douleur per- et postopératoire (seul l'AINS étudié).	A
Les benzodiazépines sont inefficaces sur la douleur de l'IVG par aspiration ; l'efficacité du paracétamol n'est pas prouvée.	AP
Pour l'anesthésie générale : les halogénés à forte concentration augmentent le volume des pertes sanguines ; l'utilisation d'ocytocine le diminue.	B

La patiente doit être informée des différentes modalités d'anesthésie possibles (générale ou locale) ; le choix du type d'anesthésie lui revient. Le recours à l'anesthésie générale doit être possible ; si retenue, elle répond aux exigences du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994. Les données anciennes sur l'augmentation des complications liées à l'AG (perforations, hémorragies, mortalité) précèdent l'utilisation du misoprostol et les mesures de surveillance actuelles. (AP)

VI-VII. Prévention infectieuse et prévention Rhésus

Volet	Recommandation
Prévention infectieuse (VI)	Bien qu'il n'existe pas de démonstration d'un bénéfice à long terme, il est recommandé, en cas d'IVG chirurgicale, d'adopter une stratégie pouvant associer : antibiothérapie en cas d'antécédent connu d'infection génitale haute ; pour toute autre situation à risque d'IST, prélèvement vaginal et/ou recherche de Chlamydiae trachomatis par PCR urinaire, avec traitement de la patiente et du(des) partenaire(s) en cas de positivité ; en l'absence de facteur de risque, les antibiotiques réduisent la fièvre post-IVG mais sans données sur un bénéfice à long terme (incohérence source disclosed : bénéfice à court terme démontré, bénéfice à long terme non démontré). (AP)
Prévention Rhésus (VII)	Systématique chez toute femme Rhésus négatif, par injection intraveineuse d'une dose standard de gamma-globulines anti-D. En cas d'IVG médicamenteuse à domicile, la prévention est faite lors de la prise de mifépristone. (AP)

VIII-IX. Suites immédiates, visite de contrôle et évaluation

Volet	Recommandation
Avant la visite de contrôle	Contraception œstroprogestative possible dès le lendemain de l'IVG (méthode médicamenteuse ou chirurgicale). Pose d'un dispositif intra-utérin (DIU) possible lors de l'examen de surveillance, ou en fin d'aspiration en cas d'IVG chirurgicale. Fiche de conseils sur les suites normales + numéro d'urgence remis à la patiente. (AP)
Visite de contrôle	Prévue entre le 14 ^e et le 21 ^e jour post-IVG. Contrôle de la vacuité utérine par examen clinique, complété par échographie selon les données de l'examen. Vérification de la compréhension et de la bonne utilisation de la contraception prescrite, et de la position d'un éventuel DIU (pose possible si non fait). Accompagnement psychologique spécifique proposé et disponible (peu de données sur le retentissement psychologique de l'IVG). (AP)
Évaluation (IX)	Les IVG doivent être déclarées. Un recueil national des données est nécessaire pour la surveillance épidémiologique et l'évaluation des pratiques ; ces données doivent être rapidement accessibles aux professionnels. (AP)

Prise en charge de l'IVG jusqu'à 14 semaines

Méthodologie, organisation, consultations, techniques, douleur, prévention, suites & sources



X. Axes de recherche future proposés (liste, non gradés)

- Comparer les techniques médicale et chirurgicale
- Améliorer la prise en charge de la douleur liée à l'IVG
- Déterminer l'utilité à long terme d'une antibioprophylaxie ou d'une antibiothérapie au cours de l'IVG
- Préciser le retentissement psychologique de l'IVG

Sources et avertissement

ANAES, « Prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines », Recommandations pour la pratique clinique, mars 2001. Élaboré en partenariat avec l'ANCIC, l'ANSFL, le CNGE, le CNGOF, la Confédération nationale du mouvement pour le planning familial, la Fédération Française de Psychiatrie, la SFAR, la SFMG et la SFTG. Mise à jour partielle en décembre 2010 (HAS) pour l'IVG médicamenteuse uniquement.

Avertissement — document de 2001, partiellement actualisé en 2010 : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des recommandations énonçables du texte source pour la partie chirurgicale et les éléments communs aux deux méthodes d'IVG, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par l'ANAES/HAS/SFAR. **Pour l'IVG médicamenteuse, se référer impérativement aux recommandations HAS de décembre 2010** (non incluses dans le PDF source de cette fiche). Le cadre légal, les techniques et les pratiques d'organisation des soins ayant pu évoluer depuis 2001/2010, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision.